

GUIA DE REFERÊNCIA INTEGRADA DE GRC

Resumo Consolidado de Conformidade: Lei nº 9.656/1998, RN nº 465/2021, RN nº 469/2021 e RN nº 566/2022

OBJETIVO DAS NORMAS REGULATÓRIAS

Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 (Marco Regulatório da Saúde Suplementar): Esta Lei dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e constitui a espinha dorsal legal do setor. Seu objetivo principal é ordenar e fiscalizar a atividade de direito privado que opera esses serviços sob a supervisão da ANS. A lei estabelece as garantias contratuais mínimas, define as segmentações assistenciais, os parâmetros rígidos de prazos máximos de carência, as regras de doenças e lesões preexistentes (DLP), o ressarcimento obrigatório ao SUS e os limites da atuação administrativa, visando salvaguardar o consumidor e mitigar abusividades contratuais ou financeiras.

Resolução Normativa ANS nº 465, de 24 de fevereiro de 2021 (Rol de Procedimentos): Esta resolução atualiza periodicamente o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, constituindo a referência taxativa de cobertura assistencial básica obrigatória para os contratos celebrados a partir de 2 de janeiro de 1999 (ou àqueles adaptados). Seu objetivo é definir com precisão técnica quais consultas, exames, cirurgias, terapias e internações têm cobertura garantida por segmentação assistencial (Ambulatorial, Hospitalar com/sem obstetrícia, Odontológico e Referência), estipulando Diretrizes de Utilização (DUT), Diretrizes Clínicas e parâmetros médico-assistenciais baseados em evidências científicas.

Resolução Normativa ANS nº 469, de 9 de julho de 2021 (Sessões Ilimitadas para TEA): Esta norma promoveu alteração cirúrgica na RN nº 465/2021 para revogar restrições quantitativas de sessões e instituir cobertura obrigatória e ilimitada de consultas e sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID F84). O objetivo é garantir a integralidade do cuidado mental multidisciplinar especializado sem barreiras financeiras ou limites de cotas anuais.

Resolução Normativa ANS nº 566, de 29 de dezembro de 2022 (Garantia de Atendimento e Prazos): Esta resolução dispõe de forma imperativa sobre a garantia de atendimento de saúde e estabelece os prazos máximos em dias úteis para a prestação dos serviços definidos no Rol da ANS. Seu objetivo regulatório primário é assegurar a tempestividade e a viabilidade do acesso do beneficiário à saúde em sua localidade (município de demanda), definindo obrigações logísticas rígidas para as operadoras na indisponibilidade ou inexistência de rede credenciada, incluindo as regras de oferta de prestador alternativo, transporte (ida e volta) e ressarcimento de custos em caso de falha de rede.

TÓPICOS CRÍTICOS E EXCEÇÕES DE ALTO IMPACTO OPERACIONAL

1. Prazos de Atendimento e as Garantias de Indisponibilidade de Rede (RN nº 566/2022)

A Regra Geral: As operadoras devem viabilizar o acesso aos procedimentos do Rol nos exatos prazos máximos (contados em dias úteis a partir da data de solicitação pelo beneficiário) no município onde o usuário os demandar, desde que este integre a área de abrangência geográfica do contrato.

EXCEÇÃO E REGRAS OPERACIONAIS CRÍTICAS:

- **Urgência/Emergência:** O prazo é estritamente **IMEDIATO** e independe de qualquer autorização prévia por parte da operadora.
- **Falha de Rede Credenciada:** Na indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado no município da demanda, a operadora é obrigada a custear o atendimento em prestador não credenciado no próprio município ou credenciado/não credenciado em município limítrofe, garantindo o **transporte de ida e volta** do paciente (e de acompanhante nos casos previstos na legislação, como menores de 18 anos, idosos e PcD).
- **Exceção ao Transporte:** A garantia de transporte **não se aplica** a procedimentos que contenham Diretrizes de Utilização (DUT) na ANS especificando expressamente que a operadora fica desobrigada de cobrir remoção ou transporte do paciente.
- **Reembolso Integral:** Caso a operadora descumpra as regras de acesso e o beneficiário custeie o serviço do próprio bolso, o reembolso integral deve ser efetuado compulsoriamente no **prazo máximo de 30 dias** após a entrega da documentação.

2. Limites Máximos de Carência e Cobertura Assistencial a Populações Especiais (Lei nº 9.656/1998, Art. 12)

A Regra Geral: A operadora pode impor carências contratuais máximas de 24 horas para urgência/emergência, 300 dias para parto a termo (fisiológico) e 180 dias para os demais casos assistenciais como consultas, internações e exames.

EXCEÇÕES ASSISTENCIAIS OBRIGATÓRIAS (ISENÇÃO DE CARÊNCIA):

- **Recém-nascido (natural ou adotivo):** Goza de cobertura assistencial garantida nos primeiros 30 dias após o parto sob o contrato do pai/mãe. A sua inscrição como dependente no plano é **isenta de carências**, desde que solicitada no prazo máximo de 30 dias a contar do nascimento ou adoção.
- **Filho Adotivo (menor de 12 anos):** Aproveita integralmente as carências já cumpridas pelo beneficiário adotante.
- **Doenças e Lesões Preexistentes (DLP):** Proíbe-se a exclusão definitiva de cobertura. Permite-se apenas a Cobertura Parcial Temporária (CPT) de até 24 meses exclusiva para procedimentos de alta complexidade (PAC) ou cirurgias. É **expressamente vedada a suspensão** da assistência à saúde do consumidor pela operadora antes que seja definitivamente concluída a prova do seu conhecimento prévio de preexistência, cujo ônus cabe à operadora.

3. Vedação de Limitação de Internação e Exclusões Lícitas (Lei nº 9.656/1998 & RN nº 465/2021)

A Regra Geral: É expressamente vedada à operadora limitar o prazo, valor ou quantidade de dias de internação hospitalar do paciente, inclusive em leitos de terapia intensiva (UTI), a critério médico assistencial.

LIMITES DAS EXCLUSÕES E REGRAS ESPECIAIS:

- **Exclusões Lícitas:** O plano-referência pode licitamente excluir: (i) tratamento cirúrgico/clínico experimental (sem registro nacional); (ii) procedimentos ou órteses/próteses com finalidades puramente estéticas; (iii) inseminação artificial; (iv) medicamentos importados sem registro na ANVISA; e (v) medicamentos de uso domiciliar.
- **Exceção aos Medicamentos Domiciliares:** Os medicamentos antineoplásicos de uso oral para tratamento do câncer (bem como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes diretos do tratamento) têm **cobertura obrigatória e inafastável**, devendo ser disponibilizados em até 10 dias após a prescrição.
- **Internação Domiciliar (Home Care):** Se oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar tradicional (com ou sem previsão em contrato), a operadora deve cobrir integralmente e obedecer às regras assistenciais da ANVISA e da Lei nº 9.656/1998, sem impor restrição de prazos.

4. Diretrizes Especiais para TEA e Terapias de Nutrição (RN nº 469/2021 & RN nº 465/2021)

A Regra Geral: Terapias especializadas e consultas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição são reguladas de acordo com as Diretrizes de Utilização (DUT) e contam com coberturas obrigatórias mínimas anuais ou limites por ano de contrato.

COBERTURAS ILIMITADAS E SUAS EXCEÇÕES DE DUT:

- **Autismo (TEA) e Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID F84):** A cobertura de consultas e sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos é **estritamente ILIMITADA** (não se aplicando qualquer limite quantitativo anual).
- **Exceção (Fonoaudiologia Não-TEA):** Para beneficiários não portadores de TEA, a fonoaudiologia continua sujeita a diretrizes quantitativas (como 24, 48 ou 96 sessões anuais de acordo com o CID e o diagnóstico). Se o caso não se enquadrar em nenhuma diretriz de utilização, a cobertura mínima do plano era de 12 sessões (porém revogada para dar lugar à ampla assistência contratual).
- **DUT de Nutrição (DUT 103):** Garante cobertura mínima de 12 sessões anuais para grupos de risco (crianças/jovens/idosos em risco nutricional, gestantes e ostomizados), 18 sessões para diabéticos dependentes de insulina, e de apenas 6 consultas por ano para os demais casos em geral.

5. Coberturas Extra-Rol e Incorporações Tecnológicas de Urgência (Lei nº 14.454/2022)

A Regra Geral: O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui a referência básica e taxativa para a cobertura dos planos de saúde contratados.

EXCEÇÃO DA TAXATIVIDADE (COBERTURA COMPULSÓRIA EXTRA-ROL):

Caso um tratamento ou procedimento prescrito pelo médico ou odontólogo assistente não esteja previsto no Rol da ANS, a operadora é obrigada a autorizá-lo, desde que preenchido um dos seguintes critérios legislativos:

- Existe comprovação da eficácia da tecnologia ou medicamento à luz das ciências da saúde, baseada estritamente em evidências científicas e plano terapêutico adequado; OU
- Existem recomendações expressas de incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação favorável de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que possua renome internacional (desde que aprovado também para seus próprios nacionais).

TABELA DE PROCEDIMENTOS E PRAZOS MÁXIMOS DE ATENDIMENTO

A tabela abaixo consolida os prazos assistenciais máximos obrigatórios estabelecidos no Artigo 3º da **Resolução Normativa ANS nº 566, de 29 de dezembro de 2022**. A sua contagem é de extrema relevância operacional para os setores de Auditoria Médica, Ouvidoria e GRC, sendo efetuada estritamente em **dias úteis** (com exceção dos métodos contraceptivos).

Procedimento / Serviço Assistencial	Prazo Máximo Definido	Tipo de Contagem	Amparo Legal (RN 566/22)
Consulta básica (Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia)	Até 7 dias	Dias Úteis	Art. 3º, I
Consulta nas demais especialidades médicas	Até 14 dias	Dias Úteis	Art. 3º, II
Consultas ou sessões com Fonoaudiólogo	Até 10 dias	Dias Úteis	Art. 3º, III
Consultas ou sessões com Nutricionista	Até 10 dias	Dias Úteis	Art. 3º, IV
Consultas ou sessões com Psicólogo	Até 10 dias	Dias Úteis	Art. 3º, V
Consultas ou sessões com Terapeuta Ocupacional	Até 10 dias	Dias Úteis	Art. 3º, VI
Consultas ou sessões com Fisioterapeuta	Até 10 dias	Dias Úteis	Art. 3º, VII
Consultas ou sessões com Enfermeiro Obstetra ou Obstetiz	Até 10 dias	Dias Úteis	Art. 3º, VIII

Procedimento / Serviço Assistencial	Prazo Máximo Definido	Tipo de Contagem	Amparo Legal (RN 566/22)
Consulta e procedimentos com Cirurgião-Dentista (Consultório)	Até 7 dias	Dias Úteis	Art. 3º, IX
Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas (Ambulatorial)	Até 3 dias	Dias Úteis	Art. 3º, X
Demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial	Até 10 dias	Dias Úteis	Art. 3º, XI
Procedimentos de Alta Complexidade (PAC)	Até 21 dias	Dias Úteis	Art. 3º, XII
Atendimento em regime de internação hospitalar eletiva	Até 21 dias	Dias Úteis	Art. 3º, XIII
Atendimento em regime de Hospital-Dia	Até 10 dias	Dias Úteis	Art. 3º, XIV
Tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral (medicamentos + adjuvantes)	Até 10 dias	Dias Úteis	Art. 3º, XV
Tratamentos antineoplásicos ambulatoriais, radioterapia de câncer e hemoterapia vinculados à internação	Até 10 dias	Dias Úteis	Art. 3º, XVI
Atendimento de Urgência e Emergência	Imediato	Tempo Real	Art. 3º, XVII
Disponibilização de métodos e técnicas de contracepção	Até 30 dias	Dias Corridos	Art. 3º, § 6º